

मूत्र डायवर्शन — अपने विकल्प चुनें

रोगी जानकारी · जब मूत्राशय निकाल दिया जाए या काम न करे तब पेशाब बाहर निकालने के तीन तरीके

WARWIKI

जब मूत्राशय निकाल दिया जाता है या काम नहीं करता, तो पेशाब को शरीर से बाहर निकालने का नया रास्ता बनाना होता है — इसे मूत्र डायवर्शन (Urinary Diversion) कहते हैं। इसके तीन मुख्य प्रकार हैं। सभी में आपकी आँत का एक हिस्सा उपयोग होता है, और मुख्य फ़र्क यह है कि रोज़ पेशाब कैसे निकालते हैं: पेट पर bag, मूत्रमार्ग से पेशाब, या catheter से खाली करना। यह शीट तीनों की तुलना करती है; हर एक के लिए अलग विस्तृत handout भी है।

तीन विकल्प

BAG पहनते हैं

Ileal Conduit

आँत का एक छोटा हिस्सा पेशाब को पेट पर एक छोटे छेद (**stoma**) तक ले जाता है, जहाँ से वह एक हल्के **bag** में लगातार निकलता रहता है। Bag को खाली और बदलते हैं। यह सबसे सरल और सबसे सामान्य तरीका है; कुछ नियंत्रित नहीं करना पड़ता।

मूत्रमार्ग से पेशाब · BAG नहीं

Orthotopic Neobladder

आँत से बना नया थैला **मूत्रमार्ग** से जोड़ा जाता है, इसलिए आप सामान्य तरीके से पेशाब करते हैं — bag नहीं। एक **समय-सारिणी** (दिन और रात) के अनुसार खाली करना सीखते हैं; कभी-कभी catheter की ज़रूरत होती है। शुरुआत में रिसाव सामान्य है।

CATHETER से खाली · BAG नहीं

Continent Cutaneous (Indiana Pouch)

आँत से बना आंतरिक थैला पेशाब जमा करता है, जिसमें एक छोटा leak-proof छेद (अक्सर **नाभि** पर) होता है। Bag नहीं — दिन में कई बार **catheter** डालकर खाली करते हैं।

शब्दों को समझें

Urinary diversion

जब मूत्राशय न हो या काम न करे तो पेशाब निकालने का नया रास्ता।

Stoma

आँत से बनी त्वचा पर एक छोटी खुलाई जिससे पेशाब निकलता है।

Conduit

आँत का छोटा हिस्सा जो पेशाब को stoma तक ले जाता है (जमा नहीं करता)।

Neobladder

आँत से बना नया मूत्राशय जो मूत्रमार्ग से जोड़ा जाता है।

Continent

leak-proof रहता है — आप तय करते हैं कब खाली करना है।

Incontinent diversion

लगातार bag में निकलता रहता है (ileal conduit)।

Catheterize

पेशाब निकालने के लिए पतली नली डालना।

Mucus

आँत से बनने वाला चिकना तरल; पेशाब में धागे जैसा दिखना किसी भी diversion के बाद सामान्य है।

मेरे लिए कौन सा सही है? सबसे अच्छा विकल्प आपकी शारीरिक बनावट, गुर्दे की कार्यक्षमता, अन्य स्वास्थ्य स्थितियों, और catheter डालने के लिए हाथ की ताकत व नज़र पर निर्भर करता है — साथ ही आपकी जीवनशैली पर भी। हर प्रकार हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होता। आपके सर्जन बताएँगे कि आपके लिए कौन से विकल्प सुरक्षित हैं।

तुलना

	Ileal Conduit	Neobladder	Continent (Indiana)
पेशाब कैसे निकलता है	अपने आप निकलता है	मूत्रमार्ग से पेशाब	Stoma से catheter
Bag पहनना?	हाँ	नहीं	नहीं
Catheter चाहिए?	नहीं	कभी-कभी	हमेशा, हर 4-6 घंटे
सर्जरी का आकार	सबसे छोटी	बड़ी	बड़ी
दैनिक देखभाल	Bag खाली & बदलें	समय पर पेशाब, दिन-रात	Catheter & flush

सर्जन से पूछें

- मेरे लिए कौन से विकल्प संभव हैं और आप क्या सुझाव देते हैं?
- हर विकल्प में **रोज़ की दिनचर्या** और देखभाल कैसी होगी?
- यह **काम, व्यायाम, नींद और अंतरंगता** पर कैसे असर डालेगा?
- मुख्य **जोखिम** क्या हैं और बाद में दूसरी प्रक्रिया की कितनी संभावना है?

तीनों में समान

- आपकी **अपनी आँत** का हिस्सा उपयोग होता है, इसलिए सर्जरी के बाद कुछ दिन पेट को ठीक होने में लगते हैं।
- पेशाब में **mucus** (चिकना तरल) सामान्य है — आँत इसे बनाती है।
- आजीवन follow-up** ज़रूरी है, जिसमें **vitamin B12** की जाँच शामिल है (आँत का हिस्सा वर्षों में B12 घटा सकता है)।
- खूब पानी पिएँ** ताकि सब साफ रहे।

याद रखने योग्य तीन बातें

- पेशाब डायवर्ट करने के तीन तरीके हैं — **bag** (ileal conduit), **मूत्रमार्ग** से पेशाब (neobladder), या छोटे छेद से **catheter** (Indiana pouch)।
- मुख्य **फ़र्क रोज़ की देखभाल** में है। सबसे अच्छा विकल्प आपके स्वास्थ्य और प्राथमिकताओं पर निर्भर है — और हर प्रकार सबके लिए संभव नहीं।
- तीनों में आँत का उपयोग होता है, इसलिए mucus, पेट को ठीक होने का समय, और आजीवन follow-up सभी में ज़रूरी है। जो विकल्प चुनें उसका विस्तृत handout पढ़ें।